

73★★★
✓✓✓

6 分間歩行試験の主要評価項目は、最大歩行距離である。

74★★★
✓✓✓

安静時 $\text{SpO}_2 \geq 93\%$ が HOT 導入の目安であり、症状や生命予後の改善効果が示されている。

75★★★
✓✓✓

安定期に $\text{PaCO}_2 \geq 55\text{Torr}$ を示す症例では、非侵襲的陽圧換気療法 (non-invasive positive pressure ventilation: NPPV) の導入が考慮される。

76★★★
✓✓✓

睡眠時無呼吸症候群の合併例では、必要に応じて持続陽圧呼吸療法と HOT を併用することが可能である。

77★★★
✓✓✓

HOT 使用者の飛行機への搭乗は禁忌である。

78★★★
✓✓✓

HOT の使用時間は 1 日 15~18 時間以上を原則とする。

79★★★
✓✓✓

HOT 使用者は鼻粘膜保護のため、加湿器の使用が推奨される。

80★★★
✓✓✓

肺気腫が下葉優位の症例では、肺容量減量手術が検討される。

81★★★
✓✓✓

重度の COPD は肺移植の適応外である。

82★★★
✓✓✓

終末期においては、アドバンス・ケア・プランニングに取り組むことが推奨される。

83★★★
✓✓✓

ホスピス・緩和ケア病棟利用の保険適用疾患である。

84★★★
✓✓✓

インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリス、肺炎球菌が主要な細菌感染性の急性増悪の起因菌となる。

85★★★
✓✓✓

急性増悪のほとんどが細菌性肺炎によるものである。

86★★★
✓✓✓

ICS 使用例では、COVID-19 急性期には ICS を休薬する。